PROTOCOLLO 59

Stabilizzazione isometrica in apertura

Rinforzare gli abbassatori e ridurre la tensione degli elevatori

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Ipermobilità
- ✓ Controllo motorio ridotto
- ✓ Fase di consolidamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Bocca leggermente aperta, lingua al palato.



Resistenza
Mano sotto il mento.



Contrazione
Spingi lievemente in apertura contro la mano.



Rilascio
Rilascia lentamente.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	5 secondi, 20 % della forza
Ripetizioni	6
Serie	2 al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Contrazioni lievi e senza movimento
- ✓ Respirazione regolare
- ✓ Nessun dolore

Errori da evitare

- ! Forza eccessiva
- ! Trattenere il respiro
- ! Movimento della mandibola

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Isometria in apertura	Spinta lieve contro la mano sotto il mento	6 x 5 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Le isometrie lievi migliorano la stabilità senza sovraccaricare l'articolazione.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.